BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa permasalahan demografi penduduk di Kabupaten Jeneponto apabila tidak ditangani secara baik, terintegrasi dan menyeluruh oleh seluruh perangkat daerah akan bermuara pada peningkatan jumlah penduduk dan ketidakseimbangan persebaran penduduk sebagai akibat dinamika kelahiran, kematian dan migrasi, sehingga diperlukan perencanaan pembangunan kependudukan;

b. bahwa Peta Jalan Pembangunan Kependudukan merupakan arah kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan perlu adanya pengaturan mengenai peta jalan pembangunan kependudukan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025- 2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 131 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7068);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2025 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2024-2029 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Jeneponto.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat PJPK adalah dokumen perencanaan pembangunan kependudukan di Kabupaten Jeneponto untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
7. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan tertib administrasi, dan harmonisasi pengendalian kualitas, perangkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
8. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang mencangkup politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
9. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, kesehatan, kemandirian, keserdasan, sebagai ukuran dasar mengembangkan kemampuan dan memenuhi kebutuhan sebagai manusia yang bertakwa, berbudayam berkepribadian, berkeluargaan dan hidup layak.

Dipindai dengan CamScanner

10. Mobilitas Penduduk adalah gerak kependudukan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintah.

Pasal 2

(1) PJPK disusun sebagai pedoman strategis dalam menyelaraskan kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan Kependudukan secara terintegrasi, terpadu, dan berkelanjutan.
(2) PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. bab I : pendahuluan;
b. bab II : arahan Pembangunan Kependudukan tahun 2025-2039;
c. bab III : rencana aksi tahun 2025-2029; dan
d. bab IV : penutup.
(3) PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) PJPK dilaksanakan secara terkoordinasi, integrasi, dan terpadu dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
(2) PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim koordinasi yang bersifat nonstruktural.

Pasal 4

(1) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Kependudukan Daerah.
(2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kebijakan dan pelaksanaan PJPK Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas tim koordinasi, dibentuk kelompok kerja.
(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. bidang pengendalian kuantitas penduduk;
b. bidang peningkatan kualitas penduduk;
c. bidang pembangunan keluarga;
d. bidang penataan persebaran dan pengelolaan mobilitas penduduk; dan
e. bidang administrasi Kependudukan.

Pasal 6

Pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 06-08-2026

BUPATI JENEPONTO,

PARIS YASIR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 06-08-2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

ASPARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2026 NOMOR 32

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 52 TAHUN 2026
TENTANG
PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025 – 2029

PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025 – 2029

BAB I
PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Peta Jalan Pembangunan Kependudukan adalah grand design pembangunan kependudukan Indonesia. Tujuannya adalah memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan untuk berkembang dan menjadi lebih tangguh, sehingga dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul dan Pembangunan Keluarga Berkualitas untuk mencapai cita-cita Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera pada tahun 2045. Pembangunan kependudukan adalah fondasi strategis bagi seluruh dimensi pembangunan di Kabupaten Jeneponto. Penduduk adalah modal dasar sekaligus subjek dari pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan dinamika kependudukan menjadi krusial.

Dokumen ini disusun sebagai respons terhadap amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 serta Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Secara spesifik, Peta Jalan ini bertujuan untuk mengintegrasikan isu-isu kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) agar tercipta pertumbuhan penduduk yang seimbang dan kualitas penduduk yang tinggi di Jeneponto, serta merupakan dokumen perencanaan yang memuat arahan dan kebijakan strategis, serta rencana aksi dalam pencapaian sasaran pembangunan kependudukan selama 5 tahun, dan mengintegrasikan program/kegiatan dan berbagai lintas sektor sehingga dapat terkoordinasi dengan baik.

Dipindai dengan CamScanner

Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025-2029 untuk Kabupaten Jeneponto pada dasarnya sejalan dengan tujuan nasional yang lebih besar, dengan penyesuaian terhadap isu dan dinamika kependudukan spesifik di tingkat daerah. Pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan mobilitas, dan administrasi kependudukan harus dikelola secara terpadu untuk memastikan sumber daya manusia Jeneponto menjadi unggul dan berdaya saing, khususnya dalam memanfaatkan bonus demografi yang mungkin terjadi. Intinya, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029 menjadi instrumen penting bagi Kabupaten Jeneponto untuk merumuskan rencana aksi nasional yang terukur dan berbasis data guna mengelola dinamika kependudukan secara komprehensif.

b. Tujuan

Tujuan umum Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Jeneponto adalah mencapai penduduk tumbuh seimbang dan penduduk berkualitas sebagai modal utama pembangunan daerah dan nasional yang berkelanjutan.

Tujuan Khusus:

1. Mengendalikan pertumbuhan dan laju pertambahan penduduk Kabupaten Jeneponto.
2. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan.
3. Memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
4. Mewujudkan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi untuk mendukung perencanaan.

c. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam periode Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Jeneponto Periode 2025-2029 adalah sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 1

Sasaran Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (2025–2029)

Dimensi Kependudukan	Sasaran Kuantitatif Utama (Contoh)
Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penurunan Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Jeneponto menjadi 2,1 anak per wanita usia subur
Peningkatan Kualitas Penduduk	Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 70,00.

Dipindai dengan CamScanner

Pembangunan Keluarga	Peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK).
Penataan Mobilitas dan Persebaran	Tercapainya keseimbangan persebaran penduduk antar wilayah kecamatan
Administrasi Kependudukan	100% penduduk Jeneponto memiliki dokumen kependudukan yang sah dan valid

d. Dasar Hukum

Penyusunan Peta Jalan ini didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah, yang mengatur urusan wajib yang berkaitan dengan kependudukan.
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
5. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 400.12/11679/Dp3a-BaldukKb Tentang Penyusunan Peta Jalan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025 – 2029.
6. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
7. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kabupaten Jeneponto.

Dipindai dengan CamScanner

a. Batasan Pengertian

Dalam dokumen ini, istilah-istilah kunci memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Pembangunan Kependudukan: Upaya terencana dan sistematis untuk mewujudkan sinergi sinkronisasi, dan harmonisasi dari lima dimensi kependudukan: pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
2. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK): Dokumen perencanaan strategis yang memuat arahan kebijakan, program, dan kegiatan prioritas di bidang kependudukan untuk jangka waktu tertentu (misalnya 5 tahun), sebagai tindak lanjut implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) daerah.
3. Pertumbuhan Penduduk Seimbang: Kondisi ideal di mana jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan berkelanjutan.
4. Kualitas Penduduk: Kondisi penduduk ditinjau dari aspek kesehatan (termasuk stunting), pendidikan, dan ketahanan ekonomi, yang diukur salah satunya melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

f. Analisis Situasi Kependudukan Kabupaten Jeneponto

Analisis ini disajikan secara ringkas berdasarkan lima dimensi Grand Design Pembangunan Kependudukan, masukan data spesifik Jeneponto harus diisi dari sumber Badan Pusat Statistik/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Tabel 2

Analisis Situasi Kependudukan Kabupaten Jeneponto

Dimensi	Gambaran Umum Situasi (Contoh)
Kuantitas Penduduk	Jumlah penduduk Jeneponto bertambah cepat, laju pertumbuhan penduduk (LPP) masih di atas rata-rata nasional/provinsi. Angka Kelahiran

Dipindai dengan CamScanner

	Remaja (ASFR) masih tinggi, menunjukkan perlunya intervensi KB dan PIK-R yang lebih masif.
Kualitas Penduduk	IPM Jeneponto masih di bawah rata-rata provinsi Sulawesi Selatan. Isu utama adalah stunting yang prevalensinya tinggi, serta rata-rata lama sekolah yang masih rendah.
Pembangunan Keluarga	Tingkat perceraian menunjukkan tren meningkat. Ketahanan ekonomi keluarga di desa/pesisir masih rentan. Partisipasi pria dalam KB (MOP) rendah.
Mobilitas dan Persebaran	Terjadi konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan/pesisir, sementara wilayah pedalaman mengalami kepadatan rendah, yang berdampak pada ketidakmerataan pelayanan dasar.
Administrasi Kependudukan	Meskipun cakupan kepemilikan KTP-el dan Akta Kelahiran sudah tinggi, akurasi dan data agregat dan pemanfaatan data Adminduk oleh sektor lain (misal: kesehatan, pendidikan) belum optimal.

Tabel 3
Analisis Situasi Kependudukan
(Indikator Pembangunan Kependudukan dengan Matriks PSRI)

No.	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat Ini)	Response (Tanggapan)	Impact (Dampak)
Pilar 1: Pengendalian Kuantitas Penduduk					
1.	**Total Fertility Rate (TFR)**	Kelompok memiliki banyak anak, dan pernikahan usia	Rata-rata anak per wanita di Kab. Jeneponto tahun 2024 sebanyak	Program Keluarga Berencana (KB);	Pencegahan pernikahan

Dipindai dengan CamScanner

No.	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat Ini)	Response (Tanggapan)	Impact (Dampak)
		muda.	2,13%	edukasi reproduksi	penduduk seimbang.
2.	Angka Kelahiran Remaja (ASFR 15-19)	Kurangnya edukasi seksual dan kesehatan reproduksi, pernikahan anak.	Jumlah kelahiran per 1.000 wanita usia 15-19 tahun di Kab. Jeneponto pada tahun 2024 34,3%.	Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), pusat informasi dan konseling remaja.	Penurunan risiko kehamilan/ kematian ibu & anak, peningkatan pendidikan remaja.
3.	Proporsi Kebutuhan KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Akses layanan KB yang terbatas, hambatan budaya/ekonomi.	Persentase PUS yang ingin menunda/ mengidentifikasi kelompok tidak menggunakan kontrasepsi baru 80,5% Masih perlu upaya ditingkatkan	Peningkatan akses & kualitas layanan KB, subsidi alat kontrasepsi.	Peningkatan penggunaan kontrasepsi, penurunan TFR.
Pilar 2: Peningkatan Kualitas Penduduk (Pendidikan)					
4.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Keterbatasan, kurangnya fasilitas sekolah di daerah terpencil.	Rata-rata tahun pendidikan yang ditempuh penduduk usia 15 tahun ke atas, baru mencapai 7,46%	Program wajib belajar 12 tahun, beasiswa, pembangunan infrastruktur pendidikan.	Peningkatan modal manusia, pertumbuhan ekonomi.
5.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	Biaya kuliah yang mahal, kurangnya daya tampung/kualitas PT.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap total penduduk usia kuliah di tahun 2024 hanya 12,2%.	Bantuan biaya pendidikan (KIP-Kuliah), peningkatan akreditasi perguruan tinggi.	Peningkatan daya saing SDM, ketersediaan tenaga ahli.
6.	Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi Kompetensi	Kualifikasi yang kurang relevan, minimnya.	Proporsi penduduk usia produktif yang memiliki sertifikasi	Pelatihan vokasi/kerja sama industri, sertifikasi	Peningkatan keterampilan kerja, penurunan

Dipindai dengan CamScanner

No.	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat Ini)	Response (Tanggapan)	Impact (Dampak)
	Kerja/Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang bekerja di bidang Kesehatan menengah tinggi	pelatihan vokasi	kompetensi hanya 0,14%	gratis.	penganggaran.
Pilar 2: Peningkatan Kualitas Penduduk (Kesehatan)					
7.	Prevalensi Stunting	Kurangnya asupan gizi ibu hamil & balita, asuransi anak.	Prevalensi balita dengan tinggi badan di bawah rata-rata mencapai 17% sesuai hasil Survei Status Gizi pada tahun 2024.	Pemberian makanan tambahan, edukasi gizi & sanitasi, perbaikan layanan kesehatan ibu & anak.	Peningkatan kualitas kesehatan dan kognitif anak, penurunan angka kesakitan.
8.	Angka Kematian Bayi/Balita / Jumlah Kasus Kematian Balita (AKB)	Kurangnya akses dan kualitas layanan kesehatan ibu & anak.	Jumlah kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, mencapai 18,55%.	Imunisasi lengkap, peningkatan fasilitas perkesmas/posyandu, edukasi kesehatan.	Peningkatan usia harapan hidup, kesejahteraan keluarga.
9.	Angka Kematian Ibu (AKI) / Jumlah Kasus Kematian Ibu	Keterbatasan pengawasan persalinan, kurangnya tenaga medis terlatih.	Jumlah kematian ibu akibat kehamilan/persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024 0,25%.	Peningkatan layanan kesehatan maternal, program safe delivery.	Menurunnya risiko kematian ibu saat melahirkan, perlindungan terhadap anak.
10.	Tingkat Kemiskinan	Tingkat pengangguran tinggi, inflasi, ketidakstabilan upah.	Persentase penduduk Kab. Jeneponto di bawah garis kemiskinan tahun 2024 sebanyak 11,83%.	Bantuan sosial tunai, pelatihan wirausaha, penciptaan lapangan kerja.	Peningkatan daya beli dan kualitas hidup masyarakat.
11.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Hambatan budaya,	Persentase wanita usia produktif yang	Cuti melahirkan, fasilitas	Peningkatan pendapatan keluarga.

Dipindai dengan CamScanner

No.	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat Ini)	Response (Tanggapan)	Impact (Dampak)
	perempuan (TPAK-P)	kurangnya fasilitas penitipan anak, diskriminasi	aktif dalam pasar kerja 57,41%	pengawasan di tempat kerja, kebijakan anti-diskriminasi	pemberdayaan ekonomi perempuan
12.	Persentase Pekerja Informal	Minimnya peluang kerja formal, rendahnya perlindungan.	Proporsi pekerja di sektor informal (tidak ada kontrak, jaminan sosial), ada 78,95%	Regulasi perlindungan pekerja informal, formalisasi usaha mikro	Peningkatan perlindungan sosial dan kesejahteraan pekerja
13.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Kurangnya Aksesibilitas dan Tingkat pendidikan yang rendah	Terdapat sekitar 20,91% pada tahun 2024 pekerja disabilitas di kategorikan bekerja di sektor formal	Pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas dan perluasan akses lapangan kerja	Peningkatan pendapatan, dan inklusi sosial dan kemandirian
14.	Gini Ratio	Ketimpangan pendapatan dan akses sumber daya.	Ukuran ketidakmerataan distribusi pendapatan (0 = merata, 1 = timpang sempurna), berada pada poin 0,304.	Pajak progresif, redistribusi asset sumber daya, program subsidi sosial.	Pencegahan konflik sosial, peningkatan kestabilan ekonomi.
15.	PDRB Per Kapita	Rendahnya produktivitas penduduk, lambatnya pertumbuhan ekonomi.	Produk Domestik Regional Bruto dibagi jumlah penduduk Tahun 2024 mencapai 33,16%	Kebijakan investasi, inovasi teknologi, peningkatan kualitas SDM	Peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rata-rata penduduk.
16.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Ketidaksesuaian antara kesempatan lulusan dengan lowongan pasar	Persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan	Bursa kerja daring, pelatihan kerja, investasi sektor	Peningkatan produksi PDRB, stabilitas sosial.

Dipindai dengan CamScanner

No.	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat Ini)	Response (Tanggapan)	Impact (Dampak)
		kerja.	sebanyak 2,46%.	padat karya.	
Pilar 3: Pembangunan Keluarga					
17.	Persentase Kepemilikan NPWP	Tekanan kebutuhan data APBD yang terus meningkat, dan penduduk usia produktif yang belum terdaftar sebagai wajib pajak	Pada tahun 2024 terdapat 29,91% penduduk usia produktif Jeneponto yang memiliki NPWP dari jumlah penduduk produktif	Integrasi NIK-NPWP, Persentase NIK yang sudah tervalidasi sebagai NPWP, dan Edukasi/Sosialisasi Pajak serta Pengembangan Layanan	Peningkatan penerimaan pajak (PPh Orang Pribadi) dan peningkatan stabilitas Fiskal
18.	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	Tingkat pengangguran, kekerasan dalam rumah tangga, minimnya waktu berkualitas	Indeks yang mengukur ketahanan dan kualitas fungsi keluarga, mencapai 55,03%.	Program Bina Keluarga Balita (BKB)/Remaja (BKR), konseling perkawinan.	Peningkatan fungsi dan ketahanan keluarga, penurunan masalah sosial.
19.	Indeks Perlindungan Anak	Adanya kasus kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian anak.	54,33%, Indeks yang mengukur tingkat pemenuhan hak dan perlindungan anak.	Pendirian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), sosialisasi UU Perlindungan Anak.	Penurunan kasus kekerasan anak, pemenuhan hak anak secara optimal.
20.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Peningkatan harga tanah/properti, kurangnya ketersediaan rumah subsidi.	Persentase rumah tangga yang tinggal di rumah layak huni sebanyak 72,86%	Program rumah subsidi/KPR bersubsidi, perizinan pembangunan rumah.	Peningkatan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.

Dipindai dengan CamScanner

No.	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat Ini)	Response (Tanggapan)	Impact (Dampak)
21.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Minimnya infrastruktur sanitasi, perilaku buang air sembarangan.	Persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas sanitasi layak hanya 0,02%.	Pembangunan MCK umum, program sanitasi berbasis masyarakat.	Penurunan penyakit berbasis lingkungan (diare, dll.), peningkatan kesehatan masyarakat.
22.	Indeks Lansia Bertayn	Kurangnya fasilitas dan program untuk lansia, perubahan	Indeks yang mengukur kualitas hidup dan pemberdayaan lansia mencapai 55,8 poin.	Program Posyandu dan Sekolah Lansia, fasilitas publik ramah lansia, dukungan sosial.	Peningkatan peran dan kesejahteraan lansia, penurunan biaya kesehatan.
Pilar 4: Penataan Persebaran & Mobilitas Penduduk					
23.	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Perubahan sosial dan teknologi, tekanan ekonomi dan tinggi risiko perilaku menyimpang remaja	Indeks Pengasuhan Keluarga pada tahun 2024 mencapai 81,6%. Hal ini masih perlu ditingkatkan.	Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Penyediaan media informasi Konseling dan Edukasi Remaja	Peningkatan kesejahteraan dan prestasi Remaja serta penurunan perilaku berisiko.
24.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	Tingginya Biaya Kesehatan	Cakupan Kepesertaan JKN di Kab. Jeneponto baru 76,13% dari jumlah penduduk	Peningkatan anggaranuan penerima bantuan iuran yang dibayar oleh pemerintah, dan program pendaftaran massal	Perlindungan Finansial, akses ke layanan yang mudah dan peningkatan derajat kesehatan.
25.	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Mandiri	Persebaran penduduknya yang belum optimal merata, fokus di perkotaan.	Proporsi desa/kelurahan yang telah menjadi Kampung KB mandiri baru 30,1% dari 113 desa/kelurahan	Pengembangan pusat pertumbuhan di daerah, pemerataan infrastruktur hingga ke desa/kelurahan.	Kualitas penduduk di pedesaan meningkat, pemerataan urbanisasi

Dipindai dengan CamScanner

No.	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat Ini)	Response (Tanggapan)	Impact (Dampak)
26.	Persentase Migrasi Keluar (Emigrasi) Bulu Net Recent Migrasi	Kurangnya peluang kerja di daerah	Tingkat pengangguran tertinggi di Kab. Jeneponto -0,45% pada tahun 2024.	Peningkatan kualitas layanan publik dan ekonomi di daerah asal	Pertumbuhan kebelangsa 80.864 penduduk di daerah, pertumbuhan pembangunan.
27.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	Adanya Prosedur administrasi, dan kurangnya kesadaran.	Persentase balita yang telah memiliki Akta Kelahiran sebanyak 93.9%	Penyederhanaan prosedur, pelayanan jemput bola (keliling).	Pemenuhan hak sipil anak, data kependudukan yang akurat
28.	Cakupan Kepemilikan Akta Cerai	Tingginya Angka Perceraian dan Minimnya pemahaman hukum	Persentase tahun 2024 yang telah memiliki Akta Cerai sebanyak 46,84%	Layanan Layanan Terintegrasi, penyederhanaan prosedur, dan Sosialisasi hukum	Validitas Data Kependudukan dan Kemudahan Akses Layanan Publik.
Pilar 5: Integrasi Data Kependudukan					
29.	Cakupan Kepemilikan Akta Nikah/kawin	Perkebunan tidak tercatat, kurangnya sosialisasi	Persentase pernikahan yang dicatat yang pernikahannya tercatat baru 25.03 pada tahun 2024	Sidang Isbat Nikah, penyuluhan hukum pernikahan.	Perlindungan hukum bagi wanita & anak, cara status perkawinan yang valid.
30	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	Kebutuhan pengurusan harta warisan, dan rendahnya kesadaran dan kepatuhan	Persentase kematian yang tercatat di Kab. Jeneponto dan diterbitkan Akta Kematiannya pada tahun 2024 mencapai 99,60%	Penyelesaian Prosedur dan integrasi Data Kematian	Perlindungan hukum Ahli Waris dan Validitas data Kependudukan serta Rekonsiliasi data epidemiologi

Dipindai dengan CamScanner

g. Isu Strategis Pembangunan Kependudukan

Berdasarkan analisis situasi di atas, ditetapkan lima isu strategis Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Jayapura:

1. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk: Bagaimana mengendalikan laju pertumbuhan penduduk secara efektif dan menurunkan TFR menuju level *replacement level* (2,1) melalui peningkatan kesertaan ber-KB dan pencegahan pernikahan dini.
2. Penanganan Stunting dan Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja: Bagaimana mengintegrasikan program kependudukan (penyiapan kehidupan berkeluarga) dengan program kesehatan daerah untuk menekan AKR dan prevalensi stunting, demi meningkatkan kualitas SDM sejak dini.
3. Kesenjangan Kualitas SDM: Bagaimana meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk mendorong kenaikan IPM, terutama di wilayah pedesaan.
4. Penguatan Ketahanan Keluarga: Bagaimana membangun ketahanan keluarga di segala dimensi (sosial, ekonomi, psikologis) sebagai unit terkecil pembangunan, khususnya melalui pemberdayaan ekonomi dan konseling keluarga.
5. Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Kebijakan: Bagaimana memastikan data kependudukan (dari Disdukcapil) menjadi basis tunggal dan akurat yang digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam merencanakan program (*data by name by address*).

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 2025-2029

Sasaran pembangunan kependudukan Kabupaten Jeneponto dalam periode 2025-2029 diarahkan pada perwujudan visi **"Penduduk Tumbuh Seimbang dan Berkualitas sebagai Pilar Utama Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan,"** yang berlandaskan pada Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto yaitu Jeneponto BerkelanjutAn, tangguH, berdAya saing, religiUs, Inklusif dan meRAju **(Jeneponto Bahagia).**

Sasaran ini dijabarkan melalui lima pilar Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).

1. Pilar I: Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pilar ini berfokus pada upaya menyeimbangkan pertumbuhan penduduk dengan daya dukung lingkungan dan kapasitas pembangunan daerah, terutama melalui program Keluarga Berencana (KB).

Aspek	Uraian
Arah Kebijakan	Menurunkan Total Fertility Rate (TFR) dan menekan Angka Kelahiran Remaja (AKR) melalui penguatan program Keluarga Berencana.
Strategi Utama	* **Peningkatan Akses KB:** Memprioritaskan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan memperluas layanan KB di fasilitas kesehatan hingga ke pelosok desa. * **Edukasi dan KIE:** Melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang masif untuk mengubah norma sosial terkait jumlah anak, serta pencegahan pernikahan usia anak/dini. * **Keterlibatan Pria:** Mendorong partisipasi aktif pria dalam program KB.

Dipindai dengan CamScanner

Aspek	Uraian
Target Kunci 2029	Total Fertility Rate (TFR) ditargetkan turun mencapai 2,1 anak per Wanita Usia Subur (WUS), dengan Angka Kelahiran Remaja (AKR) ditekan hingga di bawah 34 per 1.000 WUS usia 15-19 tahun.

2. Pilar II: Peningkatan Kualitas Penduduk

Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui perbaikan kesehatan dan pendidikan, menciptakan SDM Jeneponto yang unggul dan produktif.

Aspek	Uraian
Arah Kebijakan	Mewujudkan penduduk yang sehat, cerdas, dan produktif, dengan fokus pada peningkatan status gizi dan pemerataan akses pendidikan.
Strategi Utama	* **Intervensi Stunting Terpadu:** Melaksanakan intervensi spesifik dan sensitif secara terintegrasi lintas sektor (kesehatan, pangan, sanitasi) untuk percepatan penurunan stunting. * **Peningkatan Kapasitas SDM:** Mendorong peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan regional. * **Keseimbangan Generasi:** Memastikan kualitas penduduk di seluruh siklus hidup, dari balita hingga lansia.
Target Kunci 2029	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** ditargetkan mencapai minimal **70,80 poin**. **Prevalensi Stunting** ditekan hingga mencapai target nasional yaitu **14,0%**.

Dipindai dengan CamScanner

3. Pilar III: Pembangunan Keluarga

Pilar ini fokus pada penguatan ketahanan keluarga sebagai unit terkecil yang berdaya saing, sejahtera, dan harmonis.

Aspek	Uraian
Arah Kebijakan	Membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui penguatan delapan fungsi keluarga dan pemberdayaan ekonomi.
Strategi Utama	* **Revitalisasi Kelompok Kegiatan (Poktan):** Mengembangkan dan merevitalisasi kelompok BKB, BKR, dan BKL sebagai pusat edukasi dan konseling keluarga di tingkat desa/kelurahan. * **Pencegahan Risiko:** Penguatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) untuk menunda usia perkawinan dan mencegah perilaku berisiko pada remaja. * **Pemberdayaan Ekonomi:** Memfasilitasi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) agar mampu mandiri dan berkontribusi pada ekonomi keluarga.
Target Kunci 2029	**Persentase Keluarga Berpartisipasi Aktif dalam Poktan** ditargetkan mencapai 75%, dan terjadi peningkatan signifikan pada **Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)** Jeneponto.

4. Pilar IV: Penataan Mobilitas dan Persebaran Penduduk

Pilar ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan persebaran penduduk dan pemanfaatan ruang, selaras dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Aspek	Uraian

Dipindai dengan CamScanner

Aspek	Uraian
Arah Kebijakan	Mewujudkan persebaran penduduk yang harmonis dan seimbang, mendukung pemerataan pembangunan wilayah.
Strategi Utama	* **Sinkronisasi Tata Ruang:** Memastikan kebijakan kependudukan terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mengarahkan mobilitas dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru. * **Pembangunan Wilayah Pinggiran:** Mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja di wilayah-wilayah non-sentral untuk mengurangi konsentrasi penduduk di pusat kota. * **Fasilitasi Mobilitas:** Mengoptimalkan infrastruktur penghubung antar wilayah untuk memudahkan aksesibilitas.
Target Kunci 2025	**Indeks Keseimbangan Persebaran Penduduk Antar Kecamatan** ditargetkan mencapai skor minimal **0,80** (skala 0-1, semakin mendekati 1 semakin seimbang).

5. Pilar V: Administrasi Kependudukan (Adminduk)

Pilar ini diarahkan untuk menyediakan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif sebagai basis tunggal dalam perencanaan pembangunan daerah.

Aspek	Uraian
Arah Kebijakan	Menyediakan layanan administrasi kependudukan yang prima dan data kependudukan yang akurat untuk mendukung semua kebijakan daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Strategi Utama	Cakupan Dokumen: Mendorong percepatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan (KTP-el, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga) hingga 100% penduduk wajib. * Pemanfaatan Data: Menguatkan kerja sama dengan seluruh Perangkat Daerah (PD) agar Data Kependudukan (Dukcapil) menjadi basis tunggal perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program. * Inovasi Layanan: Menerapkan inovasi layanan Adminduk yang cepat, mudah, dan terintegrasi (layanan daring dan layanan keliling).
Target Kunci 2029	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (Akta Kelahiran dan KTP-el) ditargetkan mencapai 100% bagi penduduk wajib, dan 100% Perangkat Daerah memanfaatkan Data Dukcapil dalam perumusan kebijakannya.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 4

Tujuan Strategis, Indikator dan Target Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Jeneponto 2025-2029

No	Tujuan Strategis	Indikator	BASELINE 2024	Sumber Data	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Total Fertility Rate (TFR)	2.12	DPPKB/ BPS/ RPJMD	2.13	2.11	2.11	2.11	2.11
2	Mengatur, mengidentifikasi kelompok usia Terbentu	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	24.3	DPPKB/ BPS/ RPJMD	23,3-22,5	22,5-21,7	21,7-21	21-20,4	20,4-20
3	Meningkatkan penggunaan kontrasepsi KB yang Efektif	Proporsi Kebutuhan KB	88.5	DPPKB/ RPJMD	90	90.4	90.8	91.2	91.5
4	Meningkatkan tingkat pendidikan, SDM, Kesempatan Kerja dan kualitas hidup masyarakat.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15Tahun Keatas	7.46	Dikbud/ BPS/ RPJMD	8.15	8.92	8.82	8.83	10.00
5	Meningkatkan kualitas SDM, Meratakan pemerataan dan kesuffan akses	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	11.22	Dikbud/ BPS RPJMD	12.53	13.56	14.59	15.44	16.64
6	Peningkatan dapat saing dan produktivitas nasional	Jumlah Tenaga kerja Terserap/Luas Kesempatan Kerja	0.14	Disnaker/ Dikbud/ RPJMD	0.15	0.16	0.20	0.22	0.25
7	Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas dan Produktif dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	37.00	Dinkes / RPJMD	14.35	14.00	13.50	13.43	13.36

Dipindai dengan CamScanner

8	Meningkatkan derajat kesehatan dan peningkatan akses dan kualitas pelayanan	Angka Kematian Bayi/Balita (AKB)	18.32	Dinkes / RPJMD	12.62	11.68	10.97	10.48	9.86
9	Meningkatkan derajat kesehatan dan peningkatan akses dan kualitas pelayanan	Angka Kematian Ibu (AKI)/ Jumlah kasus kematian Ibu	0.25	Dinkes/ RPJMD	0.33	0.29	0.28	0.26	0.24
10	Menurunkan angka kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem	Tingkat Kemiskinan	11.82	Bappeda/ BPS/ RPJMD	10.63	9.13	8.81	8.17	6.31
11	Meningkatkan persentase perempuan usia kerja dan kesetaraan gender	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	57.41	Disnaker/ RPJMD	58	58.05	59	59.05	60
12	Menurunkan persentase pekerja informal dan meningkatkan proporsi pekerja formal	Persentase Pekerja Informal	78.55	Disnaker/ RPJMD	78	77	76	75	74
13	Meningkatkan proporsi pekerja disabilitas di sektor formal	Persentase Penyandang Disabilitas bekerja di Sektor Formal	25.91	Disnaker/ RPJMD	30	30	30	40	40
14	Menurunkan ketimpangan pendapatan	Gini Ratio	0.304	Bappeda/ BPS/ RPJMD	0.298	0.291	0.285	0.279	0.273
15	Meningkatkan PDRB Per Kapita	PDRB per Kapita	31.15	Bappeda/ BPS/ RPJMD	33.26	35.37	36.16	41.29	43.84
16	Mencapai kesempatan kerja penuh	Tingkat Penggunaan Tenaga	2.46	Disnaker/ RPJMD	2.38	2.29	2.30	2.31	2.02

Dipindai dengan CamScanner

17	Perluasan basis data, perpajakan dan peningkatan kepatuhan	Persentase Kepemilikan NPWP/ Penerbitan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi	46.05	KP-Pajak/ BPRMD	46.60	47.60	49.60	50.17	51.34
18	Memperkuat fungsi keluarga sebagai pilar pembangunan	Indeks Pembangunan Keluarga (I-bangga)	56.63	DPPKB/ BPRMD	58	59.4	60.7	61.0	61.3
19	Mewujudkan Kabupaten Ramah Anak	Indeks Pembangunan Anak	54.53	DPPA/ BPRMD	56	54.30	55	55.50	56.60
20	Mewujudkan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan(%)	71.86	Dinkes/ Vervol BPS/ BPRMD	77.5	80.08	82.07	85.20	87.05
21	Memastikan setiap rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi layak dan aman	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	0.02	Dinkes/ Vervol BPS/ BPRMD	2.56	3.92	4.32	4.72	5.12
22	Mewujudkan Lansia sehat, aktif, mandiri dan produktif	Indeks Lansia Berdaya	55.0	DPPKB/ Dinkes BPRMD	58.1	59.4	60.5	61.6	62.6
23	Meningkatkan kualitas remaja dan menurunkan perilaku berisiko	Indeks Pengauhan Keluarga yang Memiliki Remaja	81.6	DPPKB/ DPPA/ BPRMD	82.0	84	85	86	87
24	Mencapai Universal Helath Coverage (Cakupan Kesehatan Semesta)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	76.18	Bappeda/ BPJS/ BPRMD	83.50	84.20	84.94	85.66	86.38
25	Meningkatkan jumlah dan kualitas Kampung KB	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	50.1	DPPKB/ BPRMD	31.6	33	34.2	35.4	36.6

Dipindai dengan CamScanner

26	Mengelola dan mengendalikan arus migrasi ke daerah	Rate Nett Recent Migration	-0,45	Disnaker/ RPJMD	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
27	Memastikan 100% anak usia 0-30 bulan terdaftar dan memiliki akta kelahiran	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kelahiran Balita (0-4 tahun)	95.9	Dukcapil/ RPJMD	100	100	100	100	100
28	Penerbitan status hukum dan perlindungan hak pasca perceraian	Cakupan (Persentase) Penduduk yang memiliki Akta Cerai bagi Penduduk yang bercerai	46.84	Dukcapil/ RPJMD	50	52	56	59	62
29	Legalitas perkawinan dan perlindungan hukum keluarga	Cakupan (Persentase) Penduduk yang memiliki Akta Nikah	25.05	Dukcapil/ RPJMD	27	29	31	33	35
30	Memastikan setiap peristiwa kematian penduduk tercatat dengan resmi	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kematian bagi Penduduk yang Meninggal	99.46	Dukcapil/ RPJMD	100	100	100	100	100

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

RENCANA AKSI TAHUN 2025-2029

A. Tata Kelola Pembangunan Kependudukan

Tata kelola pembangunan kependudukan merujuk pada kerangka kerja, proses, dan sistem yang digunakan untuk mengarahkan, mengelola, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan dinamika kependudukan. Tata kelola yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa isu kependudukan terintegrasi secara holistik dalam seluruh perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Landasan dan Prinsip Dasar Tata Kelola

Tata kelola pembangunan kependudukan di Indonesia dilandasi oleh **Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009** tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta **Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014** tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).

Prinsip-prinsip utama yang harus dipegang dalam tata kelola ini meliputi:

1. **Integrasi dan Sinergi:** Kebijakan kependudukan tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dan disinkronisasikan secara vertikal (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) maupun horizontal (lintas sektor/Organisasi Perangkat Daerah).
2. **Berbasis Bukti (Evidence-Based):** Semua perencanaan dan pengambilan keputusan harus didasarkan pada data dan informasi kependudukan yang akurat, mutakhir, dan spesifik lokasi (Data By Name By Address).
3. **Partisipasi:** Melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, mitra kerja, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan masyarakat luas.
4. **Desentralisasi:** Pelaksanaan program diserahkan kepada pemerintah daerah, sesuai dengan karakteristik dan isu spesifik kependudukan di wilayah masing-masing.

Dipindai dengan CamScanner

Lingkup (Lima Pilar) Pembangunan Kependudukan

Tata kelola yang baik harus mencakup seluruh dimensi kependudukan yang dikenal sebagai Lima Pilar GDPK:

1. **Pengendalian Kuantitas Penduduk:** Mengelola pertumbuhan dan laju pertambahan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) dan intervensi yang menunda usia perkawinan.
2. **Peningkatan Kualitas Penduduk:** Meliputi upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan (termasuk gizi dan penurunan stunting), serta daya saing tenaga kerja.
3. **Pembangunan Keluarga:** Memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga (ekonomi, sosial, psikolog) melalui delapan fungsi keluarga dan pengembangan kelompok kegiatan keluarga (BKB, BKR, BKL).
4. **Penataan Mobilitas dan Persebaran Penduduk:** Mengatur arus urbanisasi, mengarahkan mobilitas, dan menyeimbangkan persebaran penduduk agar sesuai dengan daya dukung lingkungan dan pemerataan pembangunan wilayah.
5. **Administrasi Kependudukan (Adminduk):** Menjamin setiap penduduk memiliki identitas dan dokumen kependudukan yang sah, serta memastikan kelengkapan basis data kependudukan sebagai sumber data tunggal.

B. Struktur Kelembagaan dan Mekanisme Koordinasi

Tata kelola pembangunan kependudukan diinikan oleh struktur kelembagaan yang bersifat koordinatif, dimana **Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)** bertindak sebagai lini depan (*leading sector*) di tingkat pusat, dengan melibatkan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

1. Kelembagaan Lini Depan (BKKBN dan Perangkat Daerah)

Tingkat Pusat: Kemendukbangga/BKKBN memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan teknis, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), serta mengendalikan program.

Dipindai dengan CamScanner

Tingkat Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota): Urusan ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jeneponto. Lembaga ini bertanggung jawab atas operasional program di lapangan. Kelembagaan tata kerja pembangunan kependudukan di tingkat daerah dilaksanakan oleh Tim Koordinasi GDPK/PJPK Kabupaten Jeneponto, yang merupakan wadah koordinasi lintas sektor. Tim ini bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan secara efektif, terintegrasi, dan terpadu. Pelaksanaan tugas dilakukan dengan melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Dalam penyusunan dan pelaksanaan PJPK perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK/PJPK Kabupaten Jeneponto dengan struktur dan tugas sebagai berikut:

1. Pembina : Bupati Jeneponto
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto
3. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4. Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
5. Anggota : a). Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto
   b). Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto
   c). Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto
   d). Kepala Sosial Kabupaten Jeneponto
   e). Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto
   f). Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jeneponto
   g). Kepala Dinas Pemuidman, Perumahan dan Pertanahan Kabupate Jeneponto.
   h). Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jeneponto
   i). Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto
   j). Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas PPKB Kab. Jeneponto.

Dipindai dengan CamScanner

kj. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kab. Jeneponto

Tugas Tim Koordinasi Pelaksana GDPK/PJPK daerah:

1. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan PJPK
2. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program serta kegiatan pembangunan kependudukan antar sektor terkait melalui sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan PJPK
3. Mengevaluasi pelaksanaan PJPK

Dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana, untuk mendukung efektivitas penyusunan dan pelaksanaan PJPK, dapat disusun tim kelompok kerja (Pokj) dengan menyesuaikan sasaran pembangunan kependudukan dalam PJPK.

Tugas Tim Pokja GDPK/PJPK daerah:

a. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan penyusunan strategi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugas kelompok kerja.
b. Mengkoordinasikan dan/atau sinkronkan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan sesuai lingkup kewenangan bidang kelompok kerja.
c. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Menyusun rencana aksi PJPK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing Pokja

2. Mekanisme Koordinasi Lintas Sektor

Tata kelola harus menciptakan mekanisme koordinasi yang kuat, terpadu, konsisten dan berkesinambungan, dengan berbagai aspek yang perlu dilakukan, antara lain :

Penyelarasan Perencanaan: Isu kependudukan wajib diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang dikoordinasikan oleh **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitiandan Pengembangan Daerah (Bappeda).**

Dipindai dengan CamScanner

Forum Koordinasi: Pembentukan dan pengaktifan Tim Koordinasi Lintas Sektor di tingkat daerah (misalnya, Tim Percepatan Penurunan Stunting/TPPS) untuk mengatasi isu kependudukan yang kompleks dan memerlukan intervensi bersama (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, dll.).

Penggunaan Data Bersama: Administrasi Kependudukan (adminduk) yang dikelola oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)** harus dijadikan basis data tunggal untuk seluruh program, memastikan validitas penerima manfaat berbagai program pemerintah.

C. **Proses dan Instrumentasi Tata Kelola**

Untuk menjamin tercapainya sasaran, maka tata kelola pembangunan kependudukan harus didukung oleh instrumen yang terarah dan terstruktur dengan tahapan sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Penganggaran

Peta Jalan Kependudukan (PJPK): Merupakan instrumen operasional GDPK yang menjabarkan kebijakan, strategi, program, dan target tahunan yang terukur.

Penganggaran Responsif Kependudukan: Memastikan alokasi anggaran daerah (APBD) responsif terhadap isu kependudukan, tidak hanya pada lini depan (Dinas PPKB) tetapi juga di sektor-sektor pendukung (misalnya, anggaran gizi di Dinas Kesehatan).

2. Pengendalian dan Evaluasi

Sistem Informasi: Pemanfaatan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan sistem data kependudukan lainnya untuk memantau capaian program secara real-time.

Audit Kependudukan: Melakukan evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan kependudukan di daerah (misalnya, evaluasi terhadap keberhasilan menekan TFR atau AKR).

Mekanisme Akuntabilitas: Adanya laporan berkala yang transparan dan akuntabel dari pelaksana program kepada kepala daerah dan masyarakat mengenai capaian dan kendala pembangunan kependudukan.

Dipindai dengan CamScanner

3. Penguatan Sumber Daya Manusia

Kader Lapangan: Penguatan peran dan kompetensi kader-kader lapangan, seperti Penyuluh KB dan kader kesehatan di desa, sebagai ujung tombak program.

Kapasitas Kelembagaan: Peningkatan kapasitas teknis Perangkat Daerah melalui pelatihan dan pendampingan tentang metodologi perencanaan dan analisis data kependudukan.

Dengan implementasi tata kelola yang kuat dan terkoordinasi, Pemerintah Kabupaten Jeneponto dapat memastikan bahwa setiap program dan setiap kebijakan yang dikeluarkan berdampak optimal dalam mewujudkan penduduk yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan.

D. Rencana Aksi Tahun 2025 - 2029

1. Rencana Aksi Pengelolaan Kuantitas Penduduk

No	Indikator	Program	Kegiatan	Instansi Utama	Instansi Pendukung
1	Total Fertility Rate (TFR)	Pembinaan Keluarga Berencana	1. Peningkatan aksesibilitas pelayanan KB berkualitas 3. Pengembangan Pemberdayaan akses dan kualitas pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan di Jejaring	Dinas PP dan KB	Dinas Kesehatan
			2. Pengembangan pendekatan pelayanan berbasis OTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak) 4. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan		
2.	Angka Kelahiran Remaja (ASFR 15-19)	Pembinaan Keluarga Berencana	1. Pembentukan pusat konsultasi pemberdayaan pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja/Pendidikan Kesehatan. 2. Kampanye dan advokasi tentang pencegahan pernikahan anak. 3. Penyediakan fasilitas dan akses ke konseling kesehatan reproduksi. 4. Pelibatan Tokoh agama dan Masyarakat dalam kampanye pencegahan pernikahan anak.	Dinas PP dan KB	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama
3	Proporsi Kebutuhan KB yang Tidak Terpenuhi	Pembinaan Keluarga Berencana	1. Peningkatan akses dan kualitas layanan kontrasepsi. 2. Peningkatan tenaga medis terlatih yang mendampingi	Dinas PP dan KB	Dinas Kesehatan

Dipindai dengan CamScanner

			pemasangan kontrasepsi; 3. Kampanye dan KIE Alat Kontrasepsi bagi PUS; 4. Pelayanan KB ekstensif; 5. Kerjasama media untuk edukasi tentang KB		
4.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Program Pengembangan Pendidikan	1. Bantuan pendidikan untuk keluarga miskin; 2. Pengurangan pendidikan non formal dan kejar paket C; 3. Pengurangan biaya sekolah menengah atas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bappeda
5.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	Program Pengembangan Pendidikan	1. Beasiswa perguruan tinggi berbasis prestasi dan akademik; 2. Program kemitraan bantuan dengan industri lokal; 3. Sosialisasi keluarga tentang pentingnya pendidikan tinggi.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bappeda
6.	Persentase Pendudukan Bersertifikat Pelatihan	Program Pelatihan Pelatihan Kerja	1. Pelatihan berbasis kebutuhan industri; 2. Subsidi biaya sertifikasi profesi; 3. Kolaborasi dengan BLK, LPK, dan industri swasta	Disnakertrans	Dinas Perindustrian dan Kebudayaan
7.	Prevalensi Stunting	Program Percepatan Stunting	1. Meningkatkan cakupan indikator intervensi spesifik dan sensitif stunting dengan kualitas yang baik dan merata; 2. Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pengintegrasian PMT bukan saja sasaran balita dan ibu hamil tetapi mencakup juga faktor intervensi; 3. Meningkatkan kapasitas SDM kesehatan melalui pelatihan penanganan dan pencegahan gizi buruk serta pelatihan bagi kader posyandu (pendampingan dan kader dan evaluasi dan penilaian); 4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan sanitasi dengan pendekatan komunitas pendekatan perilaku.	Dinas Kesehatan	Dinas PP dan KB

Dipindai dengan CamScanner

8.	Angka Kematian Bayi/Balita (AKB)	Program Layanan Kesehatan Ibu dan Anak	1. Pengadaan layanan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir secara dengan standar pelayanan minimal; 2. Melakukan pengkoordinasi bersama dokter ahli [OBGYN dan SpA] bagi ibu hamil dalam pelayanan ANC, Kegawat daruratan dan di Unit Rujukan Maternal dan Neonatal; 3. Meningkatkan kapasitas SDM kesehatan melalui pelatihan PONED [Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar]	Dinas Kesehatan	Dinas PP dan Pb
9.	Angka Kematian Ibu	Pemberdayaan Ibu Hamil	1. Pengembangan pendekatan pelayanan berbasis ET PK (Epidemiologi Intervensi Kesehatan Berbasis); 2. Pengembangan pelayanan ibu Hamil; 3. Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan	BKKBD Daerah Dinas PP dan KB
			4. KIE Program Bangga Kencana; 5. Pemberdayaan Pelayanan KB & KR di faskes bersama dan kelompok	Dinas PP dan KB	Dinas Kesehatan
10.	Tingkat Kemiskinan	Program Pemberdayaan Masyarakat	1. Memberikan bantuan dan bantuan sekolah untuk keluarga miskin; 2. Mendorong inovasi pada tenaga di desain miskin; 3. Memberikan pelatihan wirausaha dan kursus pemberdayaan UMKM; 4. Mengembangkan ekonomi kreatif dan digital bagi masyarakat miskin; 5. Memperbaiki program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan lain-lain; 6. Memberikan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal; 7. Mengembangkan sistem penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan berbasis data sosial.	Dinas Sosial	Dinas PMD
11.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK-P)	Program Pemberdayaan Perempuan Kerja	1. Menyelenggarakan pelatihan vokasi dan pendidikan kompetensi yang memiliki gender; 2. Mendorong pelatihan kewirausahaan untuk perempuan, khususnya di wilayah pedesaan; 3. Peningkatan sistem yang	Disnakertrans	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dipindai dengan CamScanner

			melindungi hak pekerja perempuan, termasuk upah setara dan bebas dari diskriminasi serta kekerasan di tempat kerja.		
12.	Persentase Pekerja Informal	Program Pembinaan	1. Pelatihan wirausaha, digital marketing, keuangan mikro, literasi digital (misalnya pemasaran menjadi dll) 2. Kolaborasi dengan BUK, perguruan tinggi, atau LSM. 3. Kredit usaha rakyat (KUR), koperasi, fintech syariah. 4. Program permit system khusus bagi pedagang kaki lima (PKL), relokasi, pasar sehat. 5. Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk pekerja informal. 6. Subsidi iuran bagi kelompok rentan (misalnya melalui Dana Desa atau APBD).	Diskominfo	Dinas Sosial
13.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Program Pemberdayaan Masyarakat	1. Melakukan verifikasi dan validasi data penyandang disabilitas usia produktif. 2. Mengidentifikasi jenis disabilitas, latar belakang pendidikan, keterampilan, dan minat kerja. 3. Menyelenggarakan pelatihan vokasional berbasis kebutuhan pasar kerja dan kemampuan disabilitas. 4. Memberikan sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan daya saing. 5. Menyediakan pendampingan pekerja (job coach) yang memahami kebutuhan disabilitas.	Diskominfo	Dinas Sosial

Dipindai dengan CamScanner

16.	Dan Rido	Program Pemberdayaan Masyarakat	1. Subsidi pendidikan untuk keluarga miskin. 2. Program beasiswa dan afirmasi bagi siswa dari keluarga tidak mampu. 3. Pelatihan vokasi dan keterampilan kerja. 4. Integrasi dan digitalisasi data penerima bansos (DTKS). 5. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang efektif dan merata. 6. Pembangunan infrastruktur dasar (air bersih, dan sanitasi)	Dinas Sosial Dinas Pendidikan Dinas PU Dinas Kesehatan	Desa Pertanian Desa Perdagan Desa Perikanan Desa Perkebunan dan Kehutan
17.	RKAS Pelanglia	Program Pendampingan Ekonomi Lokal	1. Dan bantuan teknologi industri berbasis sumber daya lokal (pertanian, perkebunan, perikanan, dan). 2. Memberikan insentif pajak dan kemudahan investasi bagi pelaku usaha lokal. 3. Membina UMKM agar naik kelas menjadi usaha menengah dan besar. 4. Pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri lokal. 5. Kerja sama pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan industri (DUDI). 6. Pembentukan kelompok manfaat (petani/nelayan, pemuda desa, penyandang disabilitas) agar aktif berusaha ekonomi.	Dinas PMD Dinas Koperasi Dinas Pendidikan Dinas Pertanian Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perkebunan Dinas Perdagi	Gabungan Pelanglia Daerah
18.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Pelatihan Keterampilan Kerja	1. Menyelenggarakan pelatihan kerja berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal. 2. Bekerja sama dengan BLK (Balai Latihan Kerja) dan SMK untuk menyelenggarakan program magang atau praktik kerja industri. 3. Memberikan sertifikasi kompetensi agar pencari kerja lebih kompetitif. 4. Memberikan akses modal usaha mikro dan pendampingan bisnis. 5. Menyelenggarakan bursa dan jaringan distribusi hasil produksi lokal.	Disnakertrans	Dinas Koperasi Dikat Perdag
19.	Persentase Kepemilikan NPWP	Program Optimalisasi Pendataan	1. Melakukan pendataan dan pemetaan potensi pajak. 2. Menyelenggarakan	Badan Pendapatan Daerah	1. Seluruh Perangkat Daerah 2. Perbankan/BUMN

Dipindai dengan CamScanner

	Kecamatan Wajib Pajak Hasil Eksaminasi		Konseling dan edukasi pengobatan 3. Pengawasan berbasis kewilayahan		
18.	Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga)	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1. Optimalisasi fungsi keluarga; 2. Penguatan BKR, BKR, dan UPPKA; 3. Integrasi program lintas sektor (agama, pendidikan, sosial)	Dinas PP & KB	Dinas Sosial
19.	Indeks Pembangunan Anak	Program Kabupaten Layak Anak (KLA)	Penguatan sistem layanan, regulasi, dan partisipasi masyarakat.	DPPA	Seluruh Perangkat Daerah
20.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan(%)	Program Pengembangan Perumahan Rapat	1. Pendataan dan Penetapan Hunian Layak; 2. Integrasi Program Bantuan Stimulan perumahan swadaya (BSPS) dan Rehabilitasi Sosial RTLH; 3. Penyediaan Rumah Terjangkau Melalui Skema KPR Subsidi (FLPP/Tapera); 4. Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Berkelanjutan; 5. Edukasi dan Pengawasan Masyarakat dalam Pemeliharaan Hunian; 6. Kolaborasi Pendanaan Multipihak (CSR, Dana Desa, APBN/APBD)	Dinas Perumahan	Dinas PUPR
21.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman(%)	Program Pembangunan Jamban Sehat & Septic Tank Komunal	1. Pemetaan dan Verifikasi Akses Sanitasi; 2. Pengadaan Kelembagaan Pengelola Sanitasi (PW/Desa/Kelurahan) 3. Integrasi Sanitasi dalam Program Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Dinas Kesehatan	Dinas Perkimtan

Dipindai dengan CamScanner

22.	Indeks Lansia Berdaya	Program Lansia Berdaya	1. Pendataan komprehensif lansia, termasuk status kesehatan, penghidupan, kolektivitas, dan modal sosial. 2. Integrasi dengan data Puskesmas dan Dinas Sosial untuk memastikan lansia potensial dan rentan. 3. Memfungsikan atau menyelaraskan Posyandu Lansia untuk layanan kesehatan rutin (pemeriksaan tensi, gula darah, gizi). 4. Pelatihan kader lansia (motivasi, pola caregiving atau deteksi dini penyakit degeneratif). 5. Layanan dan pendapat manfaat bantuan lansia (PKH, asistensi, dan lansia disabilitas). 6. Integrasi layanan jaminan kesehatan (BPJS) dan pendampingan lansia dalam program pemberdayaan (Tagana atau relawan sosial lansia).	Dinas PP & KB	Dinas Kesehatan
23.	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Program Pengasuhan Keluarga	1. Program pelatihan pengasuhan berbasis keluarga (Parenting Class). 2. Pengisian Pesan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). 3. Kampanye "Ke Jaga Pacar Pertama".	Dinas PP dan KB	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
24.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	Program Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	1. Integrasi data penduduk dari Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan. 2. Melakukan cross-check akurasi kepesertaan JKN dengan DTKS dan data PBPU untuk mengidentifikasi warga belum terdaftar. 3. Pendataan warga miskin dan rentan yang belum masuk Pelita Kemensos atau APBD. 4. Pengaktifkan PBI Daerah (PBI-D) bagi warga miskin yang belum masuk kuota pusat.	Dinas Sosial Dinas Dukcapil BPJS Kesehatan	Dinas Kesehatan

Dipindai dengan CamScanner

25.	Pemerataan Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga Berkualitas	1. Pelatihan pengelolaan kampung berbasis data. 2. Integrasi layanan KB, kesehatan, pendidikan dalam satu lokasi. 3. Pemberdayaan ekonomi lokal; 4. Peningkatan Regulasi Integrasi dan Kolaborasi. 5. Pengukuran Ketahanan sosial keluarga	Dinas PP dan KB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan Pangan Dinas Koperasi Dinas Perindag
26.	Kota Ramah Terhadap Migrasi	—	1. Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pindah Datang Penduduk (RAD-PDD); 2. Penyusunan Buku Rencana Aksi Daerah Pindah Datang Penduduk (RAD-PDD)Tahun 2026-2030; 3. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pindah Datang Penduduk (RAD-PDD) di Kabupaten/Kota	Disdukcapil	1. Bappeda 2. Disnakertrans
27.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita (0-4 Tahun)	Program Pencatatan Kependudukan	1. Pelayanan jemput bola akta kelahiran; 2. Integrasi akta kelahiran dengan layanan posyandu/ puskesmas/RS; 3. Pelayanan daring dan mobile	Disdukcapil	1. RSUD Daerah 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial
28.	Cakupan Kepemilikan Akta Cerai	Program Pencatatan Kependudukan	1. Peningkatan Cakupan Data Akta Perceraian dalam Biodata Penduduk. 2. Pelayanan dan Pelaporan Perceraian dan Jemput Bola	Disdukcapil	Kemenag/KUA
29.	Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	Program Pencatatan Kependudukan	1. Peningkatan Cakupan Data Akta Perkawinan/Buku Nikah dalam Biodata Penduduk. 2. Melayani Semua Pelaporan Perkawinan dan Akta Jemput	Disdukcapil	Kemenag/KUA
30	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	Program Pencatatan Kependudukan	1. Penerapan Buku Pokok Pemakaman (BPP)/ Laporan Kematian dan Desa/Kelurahan 2. Pelayanan Jemput Aktif yaitu Pelayanan keliling	Disdukcapil	Pemerintah Desa/Kelurahan

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

PENUTUP

Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Jeneponto 2026-2029 merupakan komitmen kolektif yang ambisius untuk mewujudkan masyarakat Jeneponto yang **Berkualitas, Sejahtera, dan Berketahanan dalam Aspek Kependudukan**. Keberhasilan implementasi dari setiap strategi, program, dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen ini tidak akan tercapai tanpa adanya mekanisme **Monitoring dan Evaluasi (Monev)** yang terstruktur, periodik, dan adaptif.

A. Monitoring

Aspek monitoring akan menjadi proses **berkelanjutan** untuk mengamati, mencatat, dan melaporkan kemajuan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peta Jalan. Sistem monitoring di Kabupaten Jeneponto akan dirancang untuk **memberikan sinyal peringatan dini** terhadap potensi deviasi dari target yang telah ditetapkan.

Pemantauan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan merupakan bagian penting dalam menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan ini mencakup pengawasan terhadap indikator-indikator dan rencana aksi dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan. Pemantauan dilakukan secara berkala (triwulan/Semester) oleh tim Pokja GDPK/PJPK daerah melalui rapat koordinasi dan dashboard monitoring. Pemantauan pelaksanaan PJPK dilakukan melalui sistem pengawasan terintegrasi yang mencakup pemantauan kemajuan terhadap pencapaian target, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Kegiatan pemantauan bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan atau kendala yang muncul, sekaligus merumuskan rekomendasi yang bersifat korektif atau adaptif.

Dipindai dengan CamScanner

B. Evaluasi

Evaluasi merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur sejauh mana **efektivitas** dan **relevansi** program dalam mencapai tujuan pembangunan kependudukan Jeneponto. Evaluasi akan dilakukan secara berkala dan mencakup evaluasi *interim* (tengah periode) dan evaluasi akhir periode Peta Jalan.

1. Evaluasi Tengah Periode (Mid-Term Evaluation)

Pada akhir tahun 2027, akan dilakukan **Evaluasi Tengah Periode** yang komprehensif. Evaluasi ini bertujuan untuk:

- Menilai **relevansi** dan **kelayakan** tujuan Peta Jalan dalam konteks perubahan demografi dan sosial-ekonomi Jeneponto.
- Mengukur **efisiensi penggunaan** sumber daya (anggaran, SDM) dibandingkan dengan hasil yang dicapai.
- Mengevaluasi **efektivitas** keseluruhan strategi Peta Jalan.

Hasil dari evaluasi tengah periode ini akan menjadi dasar kuat untuk melakukan **penyesuaian strategis** (*strategic adjustment*) pada sisa periode Peta Jalan (2028-2029), termasuk realokasi sumber daya atau modifikasi desain program agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. *Evaluasi Akhir Periode dan Pengukuran Dampak*

Di penghujung tahun 2029, Evaluasi Akhir Periode akan fokus pada pengukuran **dampak** jangka panjang yang dihasilkan dari implementasi Peta Jalan. Hal ini mencakup:

- Pengukuran capaian IKU akhir, membandingkan realisasi dengan target lima tahun.

Dipindai dengan CamScanner

- Analisis tren data kependudukan (misalnya, penurunan angka TFR, peningkatan usia harapan hidup, peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan) sebagai bukti dampak.
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pembangunan Kependudukan

C. Pelaporan

Pelaporan merupakan perwujudan akuntabilitas publik dan administrasi pemerintahan. Mekanisme pelaporan Peta Jalan di Jeneponto akan dirancang agar **berbasis bukti, transparan,** dan **terintegrasi**. Pelaporan dilakukan untuk mendokumentasikan hasil pemantauan dan evaluasi serta menyampaikan informasi kepada pihak terkait guna pengambilan keputusan yang lebih baik. Pelaporan ini menjadi dasar bagi pemangku kebijakan dalam menyusun strategi pembangunan kependudukan yang lebih baik dan berkelanjutan. Pelaporan dilakukan untuk menjelaskan hasil monitoring dan evaluasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Rencana Aksi yang telah disusun. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada kepala daerah selaku pimpinan tertinggi eksekutif dalam pemerintahan daerah.

Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang dengan format yang baku:

- **Laporan Kemajuan Triwulanan:** Laporan cepat yang fokus pada realisasi fisik kegiatan dan serapan anggaran, disusun oleh OPD pelaksana dan dilaporkan kepada Bappeda dan Kepala Daerah.
- **Laporan Semesteran:** Laporan yang lebih komprehensif, mencakup analisis capaian outcome jangka pendek dan identifikasi hambatan operasional, serta usulan solusi.
- **Laporan Tahunan Kinerja :** Laporan akhir tahun yang merangkum keseluruhan capaian kinerja Peta Jalan selama satu tahun, disampaikan kepada legislatif (DPRD) dan publik sebagai wujud akuntabilitas.

Dipindai dengan CamScanner

- **Laporan Akuntabilitas Akhir Masa Jabatan:** Sebuah ringkasan kinerja total Peta Jalan 2025-2029 yang menjadi warisan dan acuan bagi kepemimpinan berikutnya.

BUPATI JENEPONTO,

PARIS YASIR

Dipindai dengan CamScanner